

Koľko vetrov denne je ešte normálne?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.10.2026

nefro.polascin.net

5. júna 2026

Koľko vetrov denne je ešte normálne?



Plynatosť je normálna. Výrazná zmena alebo varovné príznaky patria k lekárovi.

Kedy spozorovať?

- krv v stolici
- úbytok hmotnosti
- nočné bolesti
- zmena stolice
- chronická hnačka alebo zápcha
- anémia
- horúčka

Koľko vetrov denne je ešte normálne – priemer, čo frekvenciu ovplyvňuje a kedy spozorovať. Plynatosť je normálna; výrazná zmena alebo varovné príznaky patria k lekárovi.

Nadúvanie a odchod črevných plynov patria medzi bežné telesné prejavy, o ktorých sa v ambulancii často hovorí opatrne, niekedy s rozpakmi. Napriek tomu ide o medicínsky relevantnú tému. Pacienti sa často pýtajú, či majú „príliš veľa plynov“, či je ich trávenie v poriadku a kedy už môže ísť o príznak ochorenia.

Nová štúdia publikovaná v časopise *JAMA Network Open* prináša zaujímavé normatívne údaje o tom, ako často ľudia bežne vypúšťajú črevné plyny. Hoci téma môže pôsobiť úsmevne, jej praktický význam je jasný: aby sme vedeli hovoriť o nadmernej plynatosti, musíme najskôr vedieť, čo je ešte normálne.

Austrálska štúdia cez mobilnú aplikáciu

Výskumníčky Emily Brindalová a Danielle Bairdová pripravili občiansko-vedecký projekt s názvom **Chart Your Fart**. Išlo o mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej účastníci v reálnom čase zaznamenávali odchod črevných plynov.

Do projektu sa zapojilo viac ako 19 000 ľudí, pričom do finálnej analýzy bolo zaradených 6416 účastníkov. Súbor bol vo všeobecnosti reprezentatívny pre austrálsku populáciu.

Účastníci spolu zaznamenali **360 192 epizód odchodu črevných plynov** počas priemerne 10 dní sledovania. Jeden z účastníkov dokonca zaznamenával údaje 97 dní.

Priemer: približne päťkrát denne

Výsledok je jednoduchý a prakticky užitočný: priemerný počet zaznamenaných epizód bol približne **5 odchodov plynov denne na osobu**.

Rozptyl medzi jednotlivcami bol však výrazný. Niektorí ľudia mali epizód menej, iní viac. To je pri tráviacich prejavoch očakávané, pretože ich ovplyvňuje strava, množstvo vlákniny, črevná mikrobiota, pohyb, denný režim, lieky aj individuálna citlivosť.

Rozdiely podľa pohlavia, veku a dennej doby

Štúdia zistila, že muži zaznamenávali odchod plynov častejšie než ženy. Pri takomto type výskumu však treba počítať s možnosťou rozdielného sebazaznamenávania, takže nie je isté, či ide výlučne o biologický rozdiel.

Podľa veku bola najvyššia frekvencia v skupine **26 až 45 rokov**. Najnižšie hodnoty boli zaznamenané u mladších účastníkov vo veku **14 až 25 rokov**.

Zaujímavý bol aj denný rytmus. Frekvencia odchodu plynov počas dňa postupne stúpala a vrcholila tesne pred spaním. Najnižšia bola v skorých ranných hodinách. Tento priebeh je biologicky logický, pretože tvorba a odchod črevných plynov súvisia s príjmom potravy, trávením a bakteriálnou fermentáciou v čreve.

Vláknina, trávenie a črevné plyny

Autori sledovali aj súvislosť so samostatne hláseným príjmom vlákniny. Vzťah nebol veľmi silný, čo neprekvapuje. Trávenie nie je okamžitý proces a tvorba plynov závisí od viacerých faktorov, nielen od jedného jedla alebo jedného parametra stravy.

Všeobecne však platí, že fermentovateľné sacharidy a vláknina môžu u niektorých ľudí zvyšovať tvorbu plynov. Neznamená to, že vláknina je škodlivá. Práve naopak, má dôležitý význam pre črevné zdravie, metabolizmus aj kardiovaskulárne riziko. Problémom môže byť skôr rýchle zvýšenie jej príjmu alebo individuálna intolerancia niektorých potravín.

Limity štúdie

Najväčším obmedzením je spôsob zberu údajov. Všetky epizódy boli zaznamenané samotnými účastníkmi. Nešlo teda o objektívne meranie – niektoré epizódy mohli zostať nezaznamenané, iné mohli byť zapísané nepresne.

Ďalším limitom je spánok. Štúdia nevie spoľahlivo povedať, čo sa dialo v noci, keď účastníci spali. Údaje preto opisujú najmä vedome zaznamenané denné epizódy.

Napriek týmto obmedzeniam ide o užitočné normatívne dáta. Pre lekára aj pacienta môžu byť oporou pri rozlišovaní medzi bežným fyziologickým prejavom a stavom, ktorý si zaslúži bližšie vyšetrenie.

Kedy spozornieť?

Samotný odchod plynov, aj keď je pre pacienta spoločensky nepríjemný, väčšinou neznamená závažné ochorenie. Vyšetrenie je však vhodné zvážiť, ak je plynatosť nová, výrazne zhoršená alebo sa spája s ďalšími príznakmi.

Medzi varovné prejavy patria najmä:

- neúmyselný úbytok hmotnosti,
- krv v stolici,
- pretrvávajúce alebo nočné bolesti brucha,
- zmena charakteru stolice,
- chronická hnačka alebo zápcha,
- anémia,
- horúčky,
- začiatok ťažkostí vo vyššom veku,
- rodinná záťaž kolorektálnym karcinómom alebo zápalovým ochorením čreva.

V takýchto prípadoch už nejde iba o otázku „normálneho počtu vetrov“, ale o potrebu cielene hľadať príčinu ťažkostí.

Praktický záver

Priemerný človek podľa tejto austrálskej štúdie vypúšťa črevné plyny približne **päťkrát denne**. To však neznamená, že vyšší počet je automaticky chorobný. Dôležitý je celkový kontext: strava, pravidelnosť stolice, bolesti, nafukovanie, zmena návykov a prítomnosť varovných príznakov.

Plynatosť je normálnou súčasťou trávenia. Medicínsky problém z nej robí najmä výrazná zmena oproti doterajšiemu stavu, sprievodné ťažkosti alebo dopad na kvalitu života.

Zdroj: Medscape, „*Flatus Status: How Many Farts a Day Is Normal?*“. [medscape.com](https://www.medscape.com).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=kolko-vetrov-denne-je-este-normalne> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.